CAC
Cuenta de Alto Costo

2

Cáncer de mama

RESUMEN infográfico

Cáncer de mama

2 de enero de 2024 al 1° de enero de 2025

2

Morbimortalidad del cáncer de mama

Fue el más frecuente entre los **11 tipos de cáncer** priorizados y continúa siendo el más común entre las **mujeres.**

Se notificaron **8.876** **casos nuevos invasivos** lo que corresponde a una PCNR estandarizada de 28,69 casos nuevos por cada 100.000 mujeres (IC 95 %: 28,09 – 29,30).

Se registraron **4.883** **muertes en las mujeres** con cáncer invasivo, lo que representa una mortalidad estandarizada de 14,46 fallecimientos por cada 100.000 mujeres (IC 95 %: 14,05 – 14,88).

Desde el periodo 2020, la PCNR presentó un crecimiento del 27,58 %, mientras que la prevalencia aumentó en 190,74 casos por 100.00 habitantes.

Caracterización de los casos nuevos de cáncer de mama

El 91,92 % de los casos correspondieron a neoplasias invasivas, con una distribución similar entre los regímenes, con excepción de los CNR por los planes voluntarios de salud, en los que el 22,97 % fueron diagnosticados en etapa *in situ*.

El 82,17 % de los casos fueron manejados con terapia sistémica.

Evaluación de la gestión del riesgo en los casos de cáncer de mama

La proporción de los casos nuevos en estadios localizados al momento del diagnóstico alcanzó el 49,15 % a nivel nacional, el contributivo tuvo valores más altos que el subsidiado, pero ninguno alcanzó la meta del 60 %.

El **21,35 %** **de mujeres prevalentes con cáncer de mama** fueron evaluadas con una escala de calidad de vida.

Descargar infografía

PCNR: proporción de casos nuevos reportados.
IC: intervalo de confianza.
CNR: casos nuevos reportados.

2. Cáncer de mama

CIE10: C50-D05; CIE-O-3: C50

2.1. Morbimortalidad del cáncer de mama

El cáncer de mama continúa siendo la neoplasia más frecuente entre los 11 tipos priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social. En 2025, este tumor representó el 24,62 % de los casos nuevos en mujeres y el 28,93 % de los prevalentes. Al considerar los tumores *in situ* e invasivos, se reportaron 136.282 casos de cáncer de mama en el sexo femenino, de los cuales el 7,09 % (n= 9.656) correspondió a diagnósticos realizados durante el periodo. Además, se registraron 5.034 muertes por todas las causas en mujeres con este diagnóstico.

Este capítulo hace referencia exclusivamente al cáncer de mama en la población femenina. No obstante, se destaca que también fueron reportados 1.671 diagnósticos de esta neoplasia en hombres, de los cuales 66 correspondieron a casos nuevos del periodo. Asimismo, es de resaltar que las medidas de morbimortalidad presentadas en la **tabla 2.1** corresponden únicamente a los casos invasivos.

Tabla 2.1. Medidas de frecuencia del cáncer de mama en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Medida	Casos[1]	Medida cruda[2,3]	Medida ajustada[2,4]	IC 95 %[5]
PCNR	8.876	33,07	28,69	(28,09 - 29,30)
Prevalencia	127.117	473,68	391,83	(389,65 - 394,01)
Mortalidad[6]	4.883	18,20	14,46	(14,05 - 14,88)

[1] Incluye todos los casos de cáncer de mama invasivo en las mujeres de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Informadas por 100.000 mujeres.
[3] La población corresponde a la proyectada por el DANE para el año 2024.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
[6] **Mortalidad general:** corresponde a los casos fallecidos por todas las causas, de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

2.1.1. PCNR de cáncer de mama según la región y la entidad territorial

La región Central y Bogotá, D. C., presentaron la PCNR estandarizada más alta con más de 30 casos nuevos por 100.000 mujeres, por su parte en la Amazonía-Orinoquía se registró la más baja con menos de 20 nuevos diagnósticos **(tabla 2.2).** Los departamentos con la PCNR más alta fueron Atlántico, Antioquia y Bolívar, con 37,84, 36,40 y 36,14 respectivamente. Mientras que Vichada y Vaupés informaron menos de 10 casos nuevos en el periodo. En todos los departamentos del país fueron diagnosticados casos nuevos de cáncer de mama en mujeres.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 2.2. PCNR de cáncer de mama según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	99	761.812	13,00	15,53	(12,61 - 18,91)
Bogotá, D. C.	2.018	4.088.532	49,36	39,73	(38,01 - 41,52)
Caribe	1.757	6.128.647	28,67	28,76	(27,43 - 30,14)
Central	2.428	6.401.037	37,93	30,56	(29,33 - 31,82)
Oriental	1.359	5.032.335	27,01	23,30	(22,07 - 24,59)
Pacífica	1.215	4.423.792	27,47	22,98	(21,69 - 24,34)
Nacional	**8.876**	**26.836.155**	**33,07**	**28,69**	**(28,09 - 29,30)**

[1] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de mama invasivo en mujeres de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] La población de referencia corresponde a la proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La PCNR es informada por 100.000 mujeres.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

2.1.2. PCNR de cáncer de mama según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

En el régimen contributivo la PCNR fue mayor que en el subsidiado **(tabla 2.3).** Entre las EAPB, la PCNR más alta se observó en las entidades EPS048, EPS046 y EPS005 con 49,84, 43,02 y 42,81 casos nuevos por 100.000 mujeres afiliadas, en ese orden. Mientras que en la EPSI03, la ESS062, la EPSI06 y la EPS037 fueron diagnosticados menos de 10 CN en el periodo, dentro de la población femenina afiliada.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 2.3. PCNR del cáncer de mama según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	5.726	14.533.010	39,40	30,56	(29,76 - 31,37)
Subsidiado	2.608	10.681.309	24,42	21,35	(20,53 - 22,20)
Excepción	405	987.631	41,01	24,96	(22,37 - 27,81)
Planes voluntarios de salud	114	SD	SD	SD	SD
Especial	20	21.895	91,35	40,52	(20,42 - 99,80)
No asegurado	3	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de mama invasivo en las mujeres de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La PCNR es informada por 100.000 mujeres afiliadas.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada y los planes voluntarios de salud, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de CNR.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

2.1.3. Prevalencia del cáncer de mama según la región y la entidad territorial

La prevalencia estandarizada más alta se registró en Bogotá, D. C., seguida de la región Central. En el caso de la Amazonía-Orinoquía, presentó una cifra significativamente menor de los casos de este cáncer en mujeres, en comparación del resto del país **(tabla 2.4).** A su vez, excluyendo a Bogotá, D. C., las entidades territoriales con la mayor prevalencia fueron Antioquia, Risaralda y Quindío con más de 450 casos por 100.000 mujeres; en contraste, los departamentos de Vaupés, Vichada y Guainía presentaron menos de 100 casos. En todos los departamentos del país se identificaron casos prevalentes de cáncer de mama en la población femenina.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 2.4. Prevalencia del cáncer de mama según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	1.139	761.812	149,51	183,28	(172,75 - 194,26)
Bogotá, D. C.	28.164	4.088.532	688,85	531,35	(525,12 - 537,65)
Caribe	21.330	6.128.647	348,04	342,57	(337,98 - 347,22)
Central	37.881	6.401.037	591,79	444,82	(440,27 - 449,41)
Oriental	19.229	5.032.335	382,11	315,93	(311,43 - 320,47)
Pacífica	19.374	4.423.792	437,95	342,43	(337,54 - 347,37)
Nacional	**127.117**	**26.836.155**	**473,68**	**391,83**	**(389,65 - 394,01)**

[1] Incluye todos los casos de cáncer de mama invasivo en las mujeres de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] La población de referencia corresponde a la proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La prevalencia es informada por 100.000 mujeres.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

2.1.4. Prevalencia del cáncer de mama según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

La prevalencia estandarizada fue 1,81 veces mayor en el régimen contributivo que en el subsidiado **(tabla 2.5).** Adicionalmente, la cantidad de casos invasivos atendidos en los planes voluntarios de salud fue superior a los del régimen especial.

Al comparar por las entidades de los regímenes contributivo y subsidiado, los valores más altos se registraron en la EAS016 con 692,21 casos por 100.000 mujeres afiliadas y la EPS001 con 648,80 casos por 100.000 mujeres afiliadas. En contraste, la prevalencia más baja se evidenció en la EPSI03 con menos de 100 casos (90,24).

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 2.5. Prevalencia del cáncer de mama según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	84.816	14.533.010	583,61	430,93	(428,00 - 433,87)
Subsidiado	30.402	10.681.309	284,63	237,71	(235,00 - 240,43)
Excepción	8.138	987.631	823,99	435,67	(425,61 - 445,96)
Planes voluntarios de salud	1.564	SD	SD	SD	SD
Especial	336	21.895	1.534,60	485,08	(417,07 - 577,19)
No asegurado	88	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	1.773	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos de cáncer de mama invasivo en mujeres de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La prevalencia es informada por 100.000 mujeres afiliadas.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, entidades liquidadas y los planes voluntarios de salud, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solo se presenta el número de casos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

2.1.5. Mortalidad en las mujeres con cáncer de mama según la región y la entidad territorial

En el periodo en Bogotá, D. C., presentó la mayor mortalidad general estandarizada, seguida de la región Caribe **(tabla 2.6).** Por el contrario, la cifra más baja se presentó en la Amazonía - Orinoquía.

Los departamentos con la mayor mortalidad general estandarizada fueron: San Andrés, Providencia y Santa Catalina (20,39), Atlántico (19,68) y Valle del Cauca (17,86). Sin embargo, aunque San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentó la cifra más alta, el número de defunciones fueron de 8 mujeres con cáncer de mama durante el periodo. En contraste, Guaviare y Amazonas presentaron las cifras más bajas con 5,96 y 6,63, respectivamente. Por último, Vaupés y Guainía, con 4 y 12 casos prevalentes, respectivamente, no informaron fallecimientos en mujeres con este tipo de tumor.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 2.6. Mortalidad general del cáncer de mama según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Muertes[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	65	761.812	8,53	10,47	(8,07 - 13,33)
Bogotá, D. C.	901	4.088.532	22,04	16,30	(15,25 - 17,42)
Caribe	973	6.128.647	15,88	15,33	(14,38 - 16,33)
Central	1.346	6.401.037	21,03	14,96	(14,16 - 15,80)
Oriental	732	5.032.335	14,55	11,59	(10,75 - 12,47)
Pacífica	866	4.423.792	19,58	14,60	(13,62 - 15,64)
Nacional	**4.883**	**26.836.155**	**18,20**	**14,46**	**(14,05 - 14,88)**

[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con cáncer de mama invasivo, de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La mortalidad es informada por 100.000 mujeres.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

2.1.6. Mortalidad del cáncer de mama según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

En el periodo, el régimen contributivo presentó 0,72 más defunciones por todas las causas por 100.000 mujeres afiliadas, en comparación con el subsidiado **(tabla 2.7);** por su parte, en la población no asegurada y en el régimen especial, se notificaron menos de 10 fallecimientos.

Con respecto a las entidades, las mayores cifras se observaron en la EPS012 con 26,62 y la EAS0247 con 26,04. Por otro lado, las cifras más bajas se hallaron en las entidades EPSI06, EPSI01 y EPS04, con 2,34, 2,90 y 4,92 defunciones por 100.000 mujeres afiliadas, en ese orden. En la EPS047, no reportó fallecimientos dentro de las mujeres aseguradas con este diagnóstico.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 2.7. Mortalidad general del cáncer de mama según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	Muertes[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	2.842	14.533.010	19,56	13,63	(13,13 - 14,15)
Subsidiado	1.706	10.681.309	15,97	12,91	(12,30 - 13,56)
Excepción	169	987.631	17,11	8,56	(7,23 - 10,13)
Planes voluntarios de salud	28	SD	SD	SD	SD
Especial	8	21.895	36,54	5,36	(2,18 - 62,84)
No asegurado	1	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	129	SD	SD	SD	SD

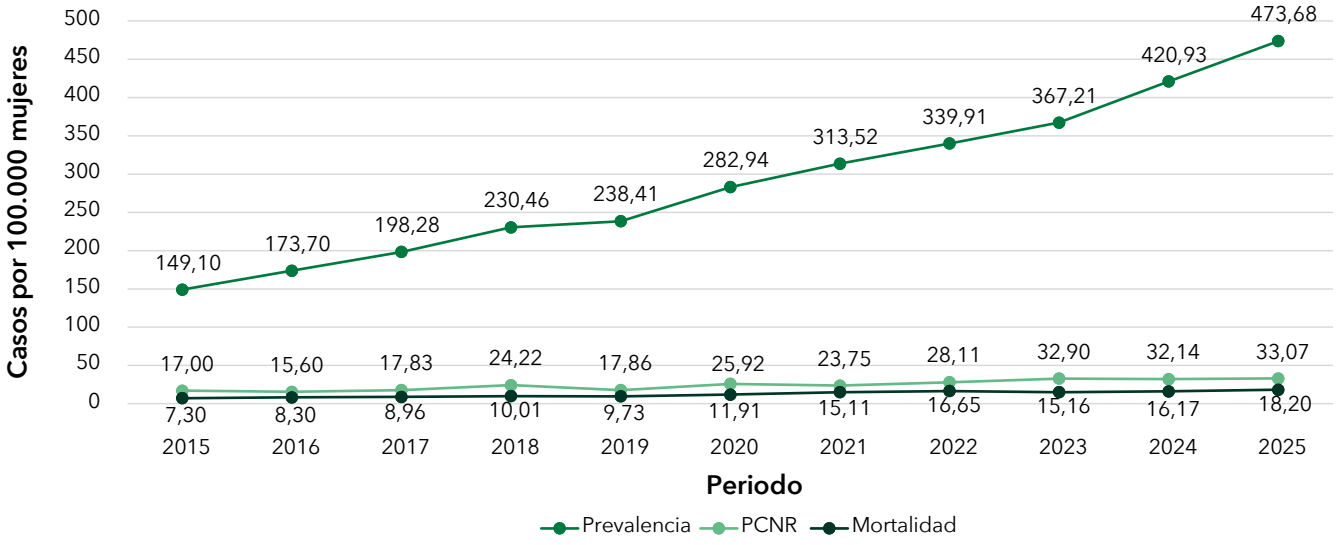
[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con cáncer de mama invasivo, de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La mortalidad es informada por 100.000 mujeres afiliadas.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solo se presenta el número de fallecidos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

2.1.7. Evolución del registro de cáncer de mama en el aseguramiento en Colombia

En la **figura 2.1** se presenta la tendencia de la morbimortalidad del cáncer de mama registrada desde 2015. A partir del periodo 2019, la prevalencia de los casos invasivos de este tipo de cáncer ha mostrado una tendencia sostenida al incremento; puntualmente, en el último periodo aumentó 12,60 % con respecto al 2024. Asimismo, los casos nuevos reportados también han aumentado; en 2025 se registraron un 2,89 % más en comparación con el periodo anterior. En conjunto, las tres medidas de morbimortalidad han incrementado durante tiempo de seguimiento.

El aumento observado en estos indicadores puede estar relacionado tanto con cambios en la frecuencia del cáncer de mama como con el fortalecimiento de los procesos de identificación, registro y reporte de los casos a la CAC, lo que ha favorecido una mayor captación de casos.

Figura 2.1. Tendencia de las medidas de frecuencia del cáncer de mama en el marco del aseguramiento, Colombia 2015 - 2025



Incluye los casos de cáncer de mama invasivo en las mujeres de la cohorte en seguimiento por la CAC.
Las medidas presentadas corresponden a valores crudos, reportados por 100.000 mujeres.
Mortalidad: corresponde al número de casos fallecidos por todas las causas de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados.
Descargar figura

2.2. Caracterización de los casos nuevos de cáncer de mama

2.2.1. Características sociodemográficas de los casos nuevos de cáncer de mama

La **tabla 2.8** presenta la caracterización general de los casos nuevos de cáncer de mama reportados en el periodo según el régimen del aseguramiento. Los casos diagnosticados presentaron una mediana de la edad de 58 años, el 3,16 % se presentó en mujeres de las etnias indígena, negra u otra y el 50,48 % residían en la región Central y en Bogotá, D. C.

Los casos de del régimen de excepción y especial presentaron una mediana de la edad mayor en comparación con el resto de los regímenes. En la distribución regional, también se observan diferencias en el aseguramiento, con una mayor concentración de los casos en la región Caribe para el subsidiado y en Bogotá, D. C., para los planes voluntarios de salud. En la población no asegurada se informaron dos casos en la región Central y uno en Bogotá, D. C.

Tabla 2.8. Caracterización sociodemográfica de los casos nuevos de cáncer de mama reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento					Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	Planes voluntarios de salud	
	n= 6.291	n= 2.755	n= 437	n= 22	n= 148	n= 9.656
	(65,15 %)	(28,53 %)	(4,53 %)	(0,23 %)	(1,53 %)	(100,00 %)
Edad	58 (48 - 68)	59 (48 - 67)	63 (53 - 72)	68 (50 - 74)	59 (48 - 68)	58 (48 - 68)
Etnia						
Ninguna	6.061 (96,34)	2.685 (97,46)	432 (98,86)	22 (100,00)	148 (100,00)	9.351 (96,84)
Indígena	11 (0,18)	40 (1,45)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	51 (0,53)
Negro	175 (2,78)	28 (1,02)	3 (0,69)	0 (0,00)	0 (0,00)	206 (2,13)
Otro[3]	44 (0,70)	2 (0,07)	2 (0,46)	0 (0,00)	0 (0,00)	48 (0,50)
Región de residencia						
Amazonía-Orinoquía	33 (0,52)	59 (2,14)	10 (2,29)	0 (0,00)	1 (0,68)	103 (1,07)
Bogotá, D. C.	1.856 (29,50)	199 (7,20)	93 (21,28)	0 (0,00)	88 (59,46)	2.237 (23,17)
Caribe	829 (13,18)	1.020 (37,02)	66 (15,10)	2 (9,09)	9 (6,08)	1.926 (19,95)
Central	1.743 (27,71)	704 (25,55)	157 (35,93)	12 (54,55)	19 (12,84)	2.637 (27,31)
Oriental	955 (15,18)	378 (13,72)	77 (17,62)	4 (18,18)	23 (15,54)	1.437 (14,88)
Pacífica	875 (13,91)	395 (14,34)	34 (7,78)	4 (18,18)	8 (5,40)	1.316 (13,63)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad en la que se presenta le mediana (rango intercuartílico).
[2] Para los valores totales se tienen en cuenta tres casos de la población no asegurada.
[3] Incluye población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, y palenquero de San Basilio.

2.2.2. Caracterización clínica de los casos nuevos de cáncer de mama reportados

A continuación, se describen las características clínicas de los casos nuevos de cáncer de mama según su afiliación al sistema de salud **(tabla 2.9).** El 91,92 % de los casos diagnosticados durante el periodo correspondió a neoplasias invasivas. Esta proporción fue similar en la mayoría de los regímenes, con excepción de los casos nuevos reportados por los planes voluntarios de salud, en los que el 22,97 % fueron diagnosticados en etapa *in situ*.

Por segundo periodo consecutivo, la proporción de casos con estadificación se mantuvo por encima del 90,00 %. Entre los casos estadificados, la mayoría fue diagnosticada en los estadios II y III, en ese orden. Asimismo, desde 2023, la proporción de casos diagnosticados en estadio IV se ha mantenido alrededor del 6,00 %.

La edad según el estadio clínico presentó rangos intercuartílicos cercanos, por lo que no se observaron diferencias relevantes en la distribución etaria de acuerdo con la estadificación. En general, la mediana de edad en los grupos con estadio *in situ*, localizados y avanzados se ubicó entre los 58 y los 61 años.

Tabla 2.9. Caracterización clínica de los casos nuevos de cáncer de mama reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento					Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	Planes voluntarios de salud	
	n= 6.291	n= 2.755	n= 437	n= 22	n= 148	n= 9.656
	(65,15 %)	(28,53 %)	(4,53 %)	(0,23 %)	(1,53 %)	(100,00 %)
Extensión[3]						
In situ	565 (8,98)	147 (5,34)	32 (7,32)	2 (9,09)	34 (22,97)	780 (8,08)
Invasivo	5.726 (91,02)	2.608 (94,66)	405 (92,68)	20 (90,91)	114 (77,03)	8.876 (91,92)
Estadificación (sí)[4]	5.918 (94,07)	2.602 (94,45)	392 (89,70)	20 (90,91)	138 (93,24)	9.070 (93,93)
Estadio al diagnóstico[4,5]						
In situ	592 (9,41)	153 (5,55)	34 (7,78)	2 (9,09)	37 (25,00)	818 (8,47)
Estadio I	1.342 (21,33)	367 (13,32)	83 (18,99)	7 (31,82)	42 (28,38)	1.841 (19,07)
Estadio II	2.513 (39,95)	1.024 (37,17)	165 (37,76)	7 (31,82)	42 (28,38)	3.751 (38,85)
Estadio III	1.201 (19,09)	827 (30,02)	74 (16,93)	2 (9,09)	16 (10,81)	2.120 (21,96)
Estadio IV	270 (4,29)	231 (8,38)	36 (8,24)	2 (9,09)	1 (0,68)	540 (5,59)
HER2[6]						
Sí	5.465 (86,87)	2.333 (84,68)	351 (80,32)	18 (81,82)	113 (76,35)	8.282 (85,77)
No	282 (4,48)	268 (9,73)	49 (11,21)	1 (4,55)	3 (2,03)	604 (6,26)
No aplica[7]	520 (8,27)	128 (4,65)	29 (6,64)	2 (9,09)	32 (21,62)	711 (7,36)
Desconocido	24 (0,38)	26 (0,94)	8 (1,83)	1 (4,55)	0 (0,00)	59 (0,61)
Resultado del HER2[8]						
Positivo (+++)	1.007 (18,43)	479 (20,53)	78 (22,22)	3 (16,67)	13 (11,50)	1.581 (19,09)
Negativo (+ o 0)	3.770 (68,98)	1.639 (70,25)	240 (68,38)	12 (66,67)	87 (76,99)	5.749 (69,42)
Equívoco/indeterminado (++)	685 (12,53)	215 (9,22)	33 (9,40)	3 (16,67)	13 (11,50)	949 (11,46)
Desconocido	3 (0,05)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	3 (0,04)
Estudio de receptores hormonales						
Sí	5.811 (92,37)	2.420 (87,84)	364 (83,30)	20 (90,91)	138 (93,24)	8.755 (90,67)
No	388 (6,17)	317 (11,51)	50 (11,44)	1 (4,55)	1 (0,68)	758 (7,85)
No aplica/desconocido	92 (1,46)	18 (0,65)	23 (5,26)	1 (4,55)	9 (6,08)	143 (1,48)
Resultado de los receptores hormonales[9]						
Positivo PgR (+) y RE (+)	3.972 (68,35)	1.453 (60,04)	247 (67,84)	15 (75,00)	100 (72,46)	5.787 (66,10)
Positivo PgR (+) o RE (+)	640 (11,01)	289 (11,94)	38 (10,44)	2 (10,00)	14 (10,14)	985 (11,25)
Negativo PgR (-) y RE (-)	1.196 (20,58)	678 (28,02)	78 (21,43)	3 (15,00)	24 (17,39)	1.979 (22,60)
PgR (no se realizó) y RE (-)	1 (0,02)	0 (0,00)	1 (0,27)	0 (0,00)	0 (0,00)	2 (0,02)
PgR (-) y RE (no se realizó)	2 (0,03)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	2 (0,02)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %), para todas las variables.
[2] Para los valores totales se tienen en cuenta tres casos de la población no asegurada.
[3] Definida según el código CIE-10.
[4] Definida según la clasificación TNM.
[5] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de mama que fueron estadificados.
[6] Determinado utilizando la técnica de inmunohistoquímica.
[7] La categoría de "no aplica" se refiere a las mujeres con cáncer de mama *in situ*.
[8] Incluye solo los casos nuevos de cáncer de mama a los que se les realizó la prueba HER2 durante el periodo.
[9] Incluye solo los casos nuevos de cáncer de mama a los que se les realizó la prueba de receptores hormonales durante el periodo.
RE: receptor de estrógeno; **PgR:** receptor de progesterona.

Con respecto a las pruebas de biomarcadores tumorales, el 93,31 % de los CNR invasivos contó con estudio de HER2, prueba indicada para este grupo de casos. Por su parte, los receptores hormonales fueron reportados en el 90,67 % del total de los casos invasivos como los *in situ*. Este porcentaje varió entre regímenes y fue mayor en el contributivo **(tabla 2.9).**

En aquellos casos a los que se les practicó la prueba de receptores hormonales, más del 60,00 % obtuvieron resultado positivo para estrógenos y progesterona. Por su parte el 22,60 % de los casos diagnosticados durante el periodo, no se les identificó alguno de estos. Aunque la proporción de casos sin evaluación de ambos receptores fue baja, es fundamental realizar las dos pruebas, dado que la expresión de estrógenos y progesterona puede diferir entre sí y su identificación conjunta aporta información clave para definir el perfil biológico del tumor y orientar el manejo terapéutico.

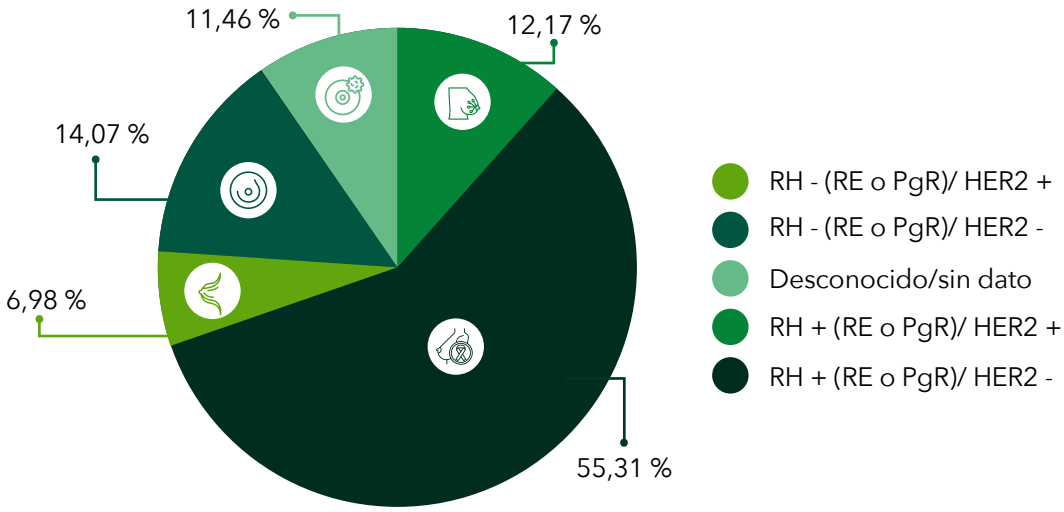
En las mujeres con resultado HER2 equívoco o indeterminado (n= 949), el algoritmo diagnóstico recomienda la realización de una prueba confirmatoria de hibridación *in situ* (FISH, SISH o DISH) para establecer el estado definitivo del biomarcador. Sin embargo, en el 54,79 % de estos casos no se reportó la realización de este estudio. Entre las pacientes con prueba confirmatoria reportada, el 18,90 % obtuvo resultado positivo (81/429) y el 81,10 % resultado negativo (348/429). Estos hallazgos evidencian una oportunidad de mejora en la realización y el reporte de las pruebas confirmatorias requeridas en los casos con resultados HER2 equívocos o indeterminados.

Tabla 2.10. Concordancia entre los resultados de las pruebas HER2 y FISH en los casos nuevos de cáncer de mama reportados en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Resultado del FISH	Resultado HER2 equívoco o indeterminado
	n (%)
Positivo	81 (8,54)
Negativo	348 (36,67)
No se realizó/desconocido	520 (54,79)
Total	**949 (100,00)**

Finalmente, las mujeres con resultados de estas dos pruebas (receptores hormonales y HER2) se dividieron acorde a los resultados, en donde el 55,31 % eran del subtipo RH positivo y HER2 negativo, seguido del 14,07 % para las que obtuvieron RH negativos y HER2 negativo, y el 12,72 % con positividad en ambas pruebas. Comparado con el periodo anterior, la proporción fue similar en aquellos casos considerados como triples negativos, a quienes se les atribuye un mayor riesgo de metástasis y recurrencia.

Figura 2.2. Distribución de los casos nuevos de cáncer de mama reportados según los resultados de las pruebas hormonales y HER2 en el marco del aseguramiento, Colombia 2025



Incluye solo los casos nuevos de cáncer de mama a los que se les realizó la prueba de receptores hormonales y la prueba HER2 durante el periodo.
RE: receptor de estrógeno; **PgR:** receptor de progesterona.

Descargar figura

2.2.3. Caracterización del tratamiento en los casos nuevos de cáncer de mama

Durante el periodo, el 85,37 % del total de casos nuevos recibió algún tipo de tratamiento. Las terapias sistémicas fueron la intervención terapéutica más frecuente, administradas al 82,17 % de los casos. Por su parte, el 54,92 % de los CN fue sometido a cirugía; de estos, el 8,80 % (n= 66) correspondió a procedimientos quirúrgicos reconstructivos. La radioterapia fue administrada al 21,10 % de los casos nuevos. En cuanto a los cuidados paliativos, 3.919 casos recibieron este tipo de atención, de los cuales el 62,52 % se encontraba en estadios II y III.

De los casos que no reportaron tratamiento durante el periodo (n= 1.413), el 36,52 % (n= 516) correspondió a mujeres diagnosticadas en los dos meses previos a la fecha de corte del seguimiento, 88 fallecieron antes de iniciar tratamiento y en 156 casos se desconocía el estadio clínico.

En la **tabla 2.11** se presenta la distribución del tratamiento reportado según la estadificación clínica a momento del diagnóstico. La terapia sistémica fue administrada con mayor frecuencia en los casos diagnosticados en estadios III y IV. Por su parte, la cirugía fue la modalidad de tratamiento más frecuente en los casos *in situ* y en estadio I, mientras que la radioterapia presentó la mayor proporción en el estadio II. En cuanto a los procedimientos reconstructivos, estos se realizaron con mayor frecuencia en los casos *in situ* y en los estadios I y II.

Tabla 2.11. Frecuencia del tratamiento prescrito en los casos nuevos de cáncer de mama según el estadio clínico en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

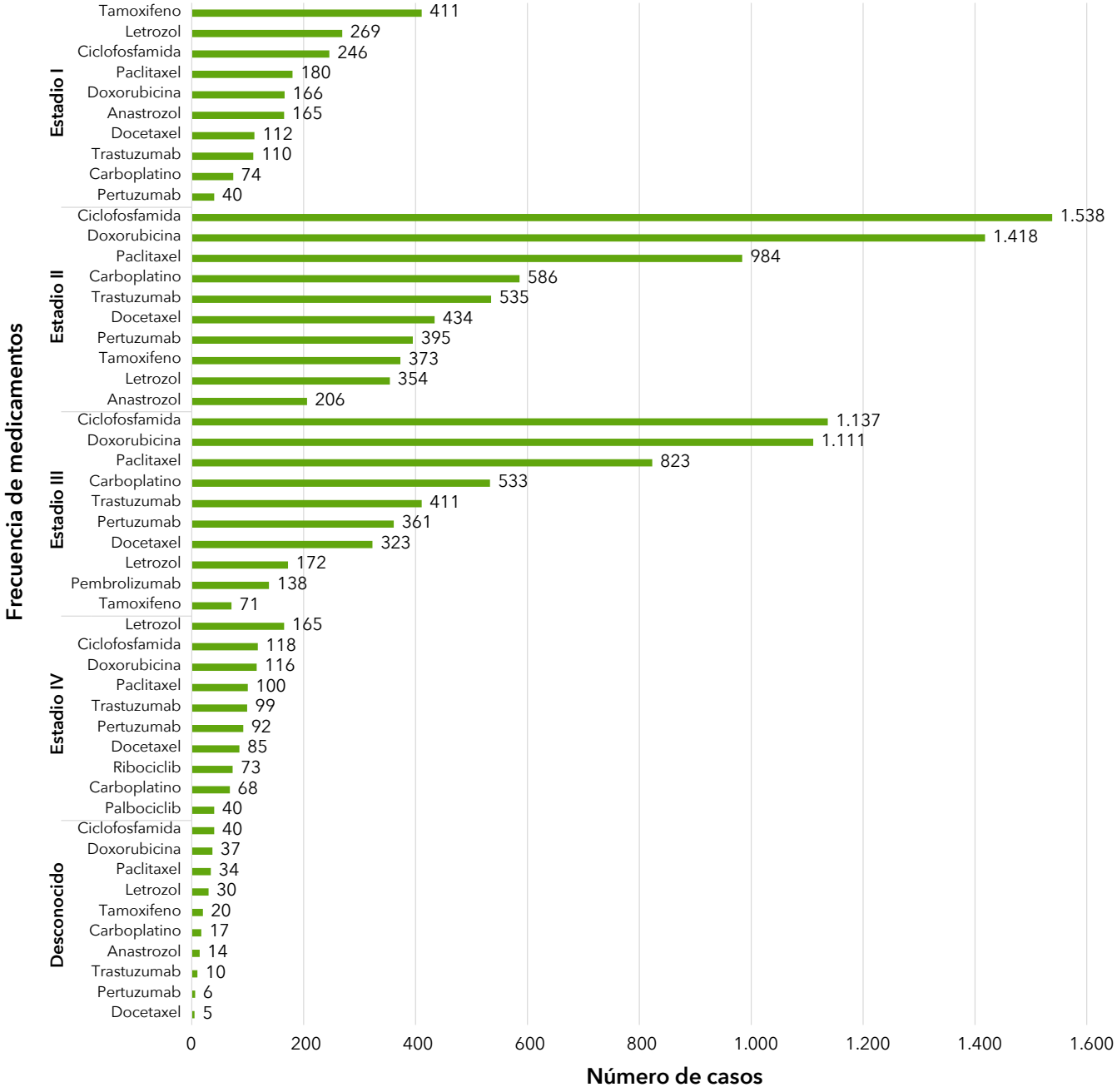
Variables	Estadio al diagnóstico						
	In situ	Estadio I	Estadio II	Estadio III	Estadio IV	Desconocido	Total
	n= 818	n= 1.841	n= 3.751	n= 2.120	n= 540	n= 586	n= 9.656
	(8,47 %)	(19,07 %)	(38,85 %)	(21,96 %)	(5,59 %)	(6,07 %)	(100,00 %)
Casos que recibieron algún tratamiento	723 (88,39)	1.642 (89,19)	3.294 (87,82)	1.886 (88,96)	475 (87,96)	223 (38,05)	8.243 (85,37)
Tipo de tratamiento prescritos[1]							
Terapia sistémica[2]	375 (51,87)	1.132 (68,94)	2.867 (87,04)	1.833 (97,19)	442 (93,05)	124 (55,61)	6.773 (82,17)
Cirugía	670 (92,67)	1.447 (88,12)	1.726 (52,40)	501 (26,56)	43 (9,05)	140 (62,78)	4.527 (54,92)
Radioterapia	216 (29,88)	625 (38,06)	589 (17,88)	164 (8,70)	111 (23,37)	34 (15,25)	1.739 (21,10)
Cirugia reconstructiva	14 (1,94)	19 (1,16)	21 (0,64)	7 (0,37)	2 (0,42)	3 (1,35)	66 (8,80)

[1] Las categorías de tratamiento no son mutuamente excluyentes; un mismo paciente pudo haber recibido más de un tipo de tratamiento.
[2] En este grupo se incluyen la quimioterapia y otras terapias sistémicas.

La **figura 2.3** describe los medicamentos administrados con mayor frecuencia en las mujeres con nuevo diagnóstico de cáncer de mama. Durante 2025, las moléculas terapéuticas administradas con mayor frecuencia en los casos nuevos de cáncer de mama variaron según el estadio clínico. En los estadios II y III predominaron los medicamentos asociados a esquemas de quimioterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia, como la ciclofosfamida, la doxorrubicina, el paclitaxel, el carboplatino, el docetaxel, el trastuzumab y el pembrolizumab, además de terapias endocrinas como el letrozol, el anastrozol y el tamoxifeno. En los estadios avanzados también se identificó el uso de moléculas como el ribociclib y el palbociclib, inhibidores de CDK4/6 indicados en este tipo de estadio. En contraste, en los casos *in situ* y en estadio I, los medicamentos más frecuentes fueron el tamoxifeno y el letrozol.

Es importante puntualizar que los datos presentados corresponden a las frecuencias de prescripción, sin tener en cuenta el uso concomitante de uno o más fármacos.

Figura 2.3. Distribución de los medicamentos prescritos con mayor frecuencia en los casos nuevos de cáncer de mama según el estadio en el marco del aseguramiento, Colombia 2025



Incluye casos de cáncer invasivo y todas las edades.

Descargar figura

2.3. Caracterización de los casos prevalentes de cáncer de mama

En los casos prevalentes de cáncer de mama informados en el periodo, la mediana de la edad fue de 64 años (RIC: 54 - 72), la población no asegurada presentó la mediana más baja, mientras que en el régimen especial se observaron edades más altas, sin que esto implique necesariamente una mayor proporción de casos avanzados.

La mayoría residían en Bogotá, D. C., y la región Central y un 1,26 % de los casos pertenecían a la etnia negra. Según el régimen del aseguramiento, la mayor proporción de casos en población indígena se concentró en el régimen subsidiado, mientras que los casos en la población afrodescendiente fueron más frecuentes en el contributivo.

La distribución geográfica según la región de residencia también mostró variaciones entre los grupos del aseguramiento. Los casos en la población no asegurada se concentraron en la región Oriental, los afiliados a planes voluntarios de salud en Bogotá, D. C., y los del régimen subsidiado en la región Caribe.

Tabla 2.12. Caracterización sociodemográfica de los casos prevalentes de cáncer de mama según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento						Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	Planes voluntarios de salud	No asegurado	
	n= 91.596	n= 31.911	n= 8.592	n= 374	n= 1.786	n= 90	n= 134.349
	(68,18 %)	(23,75 %)	(6,40 %)	(0,28 %)	(1,33 %)	(0,07 %)	(100,00 %)
Edad	64 (55 - 72)	62 (53 - 71)	67 (58 - 75)	71 (63 - 78)	64 (54 - 74)	58 (46 - 67)	64 (54 - 72)
Etnia							
Ninguna	90.325 (98,61)	30.979 (97,08)	8.356 (97,25)	374 (100,00)	1.783 (99,83)	90 (100,00)	131.907 (98,18)
Indígena	54 (0,06)	518 (1,62)	5 (0,06)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	577 (0,43)
Negro	1.093 (1,19)	374 (1,17)	220 (2,56)	0 (0,00)	1 (0,06)	0 (0,00)	1.688 (1,26)
Otro[3]	124 (0,14)	40 (0,13)	11 (0,13)	0 (0,00)	2 (0,11)	0 (0,00)	177 (0,13)
Región de residencia							
Amazonía-Orinoquía	471 (0,51)	615 (1,93)	100 (1,16)	0 (0,00)	9 (0,50)	0 (0,00)	1.195 (0,89)
Bogotá, D. C.	23.291 (25,43)	3.494 (10,95)	1.635 (19,03)	33 (8,82)	1.073 (60,08)	19 (21,11)	29.545 (21,99)
Caribe	10.660 (11,64)	9.894 (31,00)	1.657 (19,29)	22 (5,88)	167 (9,35)	3 (3,33)	22.403 (16,68)
Central	29.678 (32,40)	7.979 (25,00)	2.615 (30,44)	161 (43,05)	171 (9,57)	15 (16,67)	40.619 (30,23)
Oriental	13.460 (14,69)	4.695 (14,71)	1.528 (17,78)	50 (13,37)	207 (11,59)	47 (52,22)	19.987 (14,88)
Pacífica	14.036 (15,32)	5.234 (16,40)	1.057 (12,30)	108 (28,88)	159 (8,90)	6 (6,67)	20.600 (15,33)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad en la que se presenta la mediana (rango intercuartílico).
[2] No se incluyen los datos de 1.933 casos prevalentes, correspondientes a EAPB liquidadas en años previos, de los que no se tiene la información actualizada.
[3] Incluye población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia y palenqueros de San Basilio.

2.4. Indicadores de la gestión del riesgo en cáncer de mama

Los siguientes son los indicadores prioritarios para la medición, evaluación y monitoreo de la gestión del riesgo por parte de los aseguradores y de los prestadores en las mujeres con cáncer de mama en el marco del aseguramiento en Colombia, los cuales fueron definidos en la actualización del consenso 2025 (1):

- **1.1.** Proporción de mujeres con cáncer de mama a quienes se les realizó estadificación TNM en CNR.
- **1.2.** Proporción de mujeres con cáncer de mama a quienes se les realizó estadificación TNM en prevalentes.
- **2.** Proporción de mujeres con cáncer de mama detectado como carcinomas *in situ* al momento del diagnóstico.
- **3.** Proporción de mujeres con cáncer de mama detectado como localizado al momento del diagnóstico.
- **4.1.** Proporción de mujeres con cáncer de mama detectado como localmente avanzado en el momento del diagnóstico.
- **4.2.** Proporción de mujeres con cáncer de mama detectado como metastásico en el momento del diagnóstico.

5. Proporción de mujeres con diagnóstico histopatológico antes de la cirugía.

6. Proporción de mujeres con cáncer de mama con resultado de receptores hormonales (estrógenos/progesterona).

7. Proporción de mujeres con cáncer de mama invasivo con estudio de HER2.

7.1. Proporción de mujeres con cáncer de mama invasivo con estudio de HER2 equívoco o indeterminado (inmunohistoquímica ++) y una prueba de hibridación *in situ* (ISH).

8. Proporción de mujeres incidentes con cáncer de mama de 50 años o menos, en las que se realizó un panel multigénico.

9. Proporción de mujeres incidentes con cáncer de mama invasivo y axila clínicamente negativa, que se sometieron a una biopsia de ganglio centinela antes del inicio del tratamiento.

10.1. Proporción de mujeres con cáncer de mama *in situ* a quienes se les realizó cirugía conservadora de la mama.

10.2. Proporción de mujeres con cáncer de mama localizado a quienes se les realizó cirugía conservadora de la mama.

10.3. Proporción de mujeres con cáncer de mama localmente avanzado a quienes se les realizó cirugía conservadora de la mama.

11. Proporción de pacientes con cáncer de mama a quienes se les realizó radioterapia después de la cirugía conservadora de la mama.

12. Proporción de mujeres con receptores hormonales positivos a quienes se les administra bloqueo hormonal como tratamiento.

13. Proporción de mujeres con resultado positivo para HER2 en inmunohistoquímica que recibieron terapia anti-HER2.

14.1. Proporción de mujeres incidentes con cáncer de mama metastásico y valoración por cuidados paliativos.

14.2. Proporción de mujeres prevalentes con cáncer de mama metastásico y valoración por cuidados paliativos.

15. Proporción de mujeres incidentes con cáncer de mama y mastectomía radical que fueron a radioterapia.

16. **Oportunidad de la atención general:** tiempo entre la consulta por presencia de síntomas hasta el primer tratamiento.

17. **Oportunidad de la atención en cáncer:** tiempo entre el diagnóstico hasta el primer tratamiento.

18. **Oportunidad de la atención por el médico tratante:** tiempo entre el informe histopatológico válido y la atención por el médico tratante.

19. **Oportunidad de inicio del tratamiento:** tiempo entre la atención por el médico tratante hasta el primer tratamiento.

20. **Oportunidad de inicio de terapia adyuvante:** tiempo desde la cirugía hasta primer tratamiento postquirúrgico (quimioterapia/radioterapia/bloqueo hormonal).

21. **Oportunidad de inicio del tratamiento quirúrgico posterior a la quimioterapia neoadyuvante:** tiempo desde el último ciclo de neoadyuvancia con quimioterapia hasta la cirugía de control local o locorregional del cáncer.

22. **Oportunidad del diagnóstico:** tiempo entre la primera consulta por sospecha de cáncer de mama y la confirmación histopatológica.

23. **Oportunidad para la realización de la prueba de hibridación *in situ* (ISH):** tiempo transcurrido desde la fecha del resultado indeterminado de HER2 equívoco o indeterminado (inmunohistoquímica ++) y la prueba de hibridación *in situ* (ISH).

24.1. Letalidad de cáncer de mama (estadios localizados).

24.2. Letalidad de cáncer de mama (localmente avanzados).

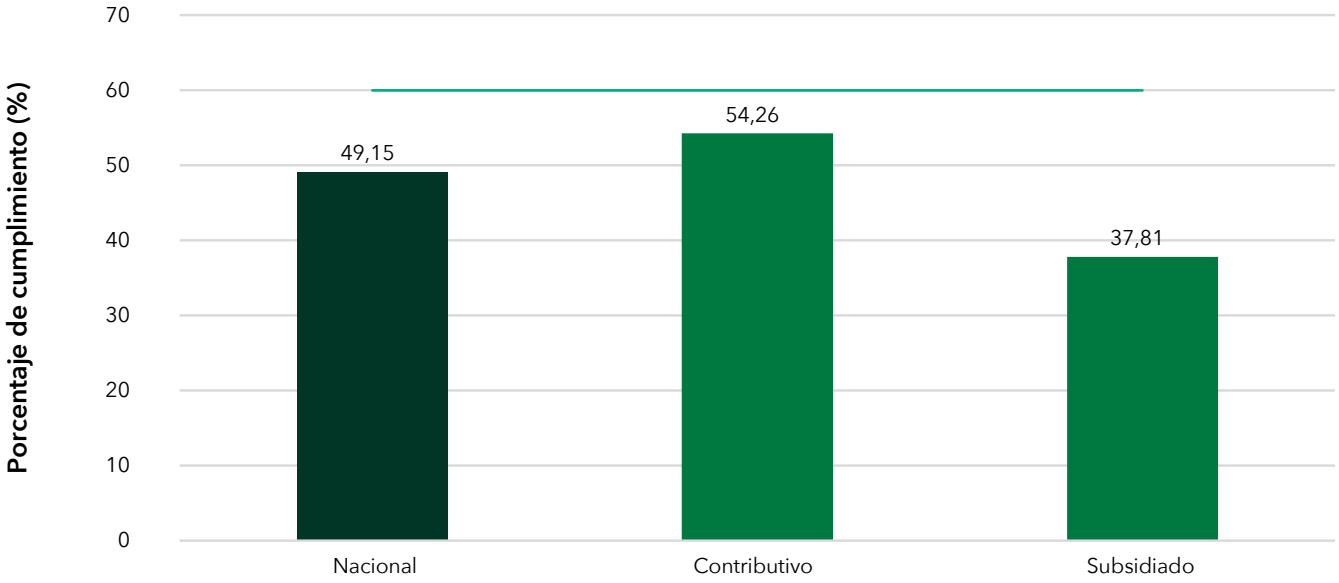
25. Mortalidad general en mujeres con cáncer de mama.
26. Supervivencia general a los 5 años.
27. Fragmentación de la atención en las mujeres prevalentes con cáncer de mama.
28. Proporción de mujeres incidentes con cáncer de mama invasivo que iniciaron tratamiento con diagnóstico inmunohistoquímico incompleto.
29. Proporción de mujeres prevalentes con cáncer de mama que completan el esquema de terapia antineoplásica prescrito.
30.1. Proporción de mujeres incidentes con cáncer de mama evaluadas con una escala de calidad de vida.
30.2. Proporción de mujeres prevalentes con cáncer de mama evaluadas con una escala de calidad de vida.
31. Proporción de mujeres con cáncer de mama con novedad de abandono en el periodo evaluado.

Puede consultar los datos de la gestión del riesgo con una mayor desagregación ingresando a HIGIA.

La información de los indicadores 9, 25 y 26 no se presenta para este periodo por las siguientes razones. El indicador relacionado con la mortalidad se presenta en la sección de morbimortalidad de este capítulo. Con respecto al de supervivencia, se presentaron nuevas estimaciones para el periodo 2024 en el informe especial "Resultados de supervivencia global en las personas atendidas en el marco del sistema de salud colombiano y notificadas a la Cuenta de Alto Costo 2014-2022" (2). Por otro lado, para este periodo no se realizó la medición de la proporción de mujeres con cáncer de mama invasivo y axila clínicamente negativa, que se sometieron a una biopsia de ganglio centinela antes del inicio del tratamiento; esto, por falta de información adicional a la solicitada según la resolución para el reporte de las entidades para cáncer.

También, con la actualización de los indicadores, se ajustó la meta de la detección en estadios localizados al 60 %, el resultado del país no alcanzó un cumplimiento para este indicador. Sin embargo, entre los regímenes de afiliación se presenta una brecha con un mayor alcance en las afiliadas al régimen contributivo.

Figura 2.4. Proporción de los casos nuevos de cáncer de mama en estadios localizados al momento del diagnóstico en cáncer de mama en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

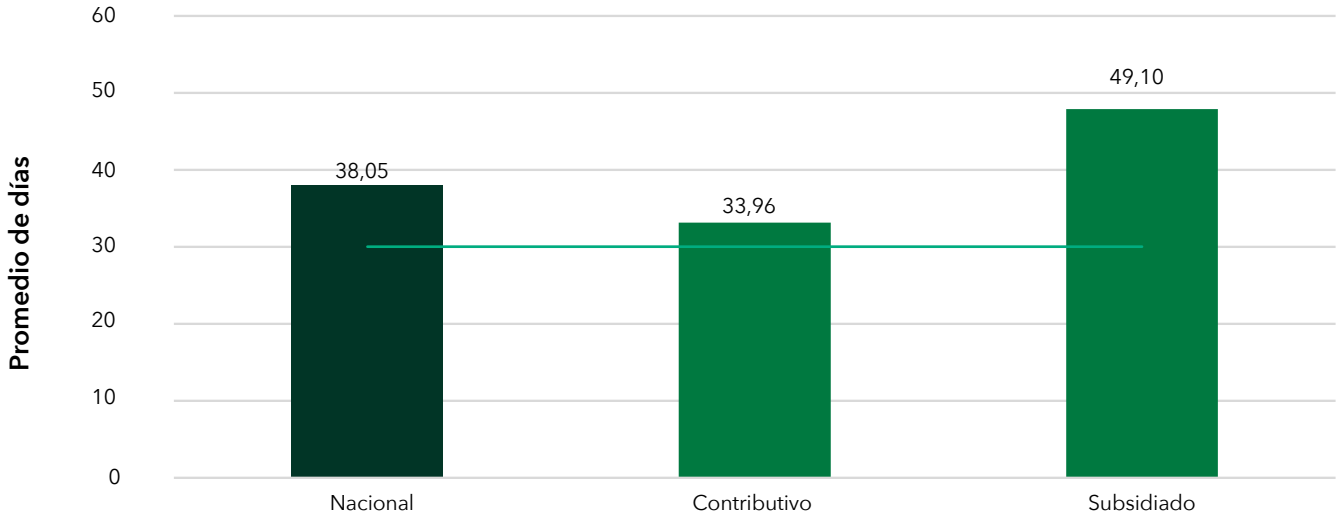


Incluye los estadios IA, IB y IIA.

Descargar figura

Uno de los nuevos indicadores definidos por el consenso de expertos es la oportunidad en la confirmación diagnóstica, la cual que define el lapso entre la remisión o sospecha hasta el diagnóstico histopatológico. Los primeros resultados calculados para esta oportunidad nos indican que en el país se supera por 8 días en promedio, la meta de los 30 días. A su vez, La diferencia entre los regímenes fue de cerca de 15 días en promedio, siendo más prolongada la espera para aquellas mujeres afiliadas al régimen subsidiado.

Figura 2.5. Oportunidad de la confirmación diagnóstica de los casos nuevos de cáncer de mama en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

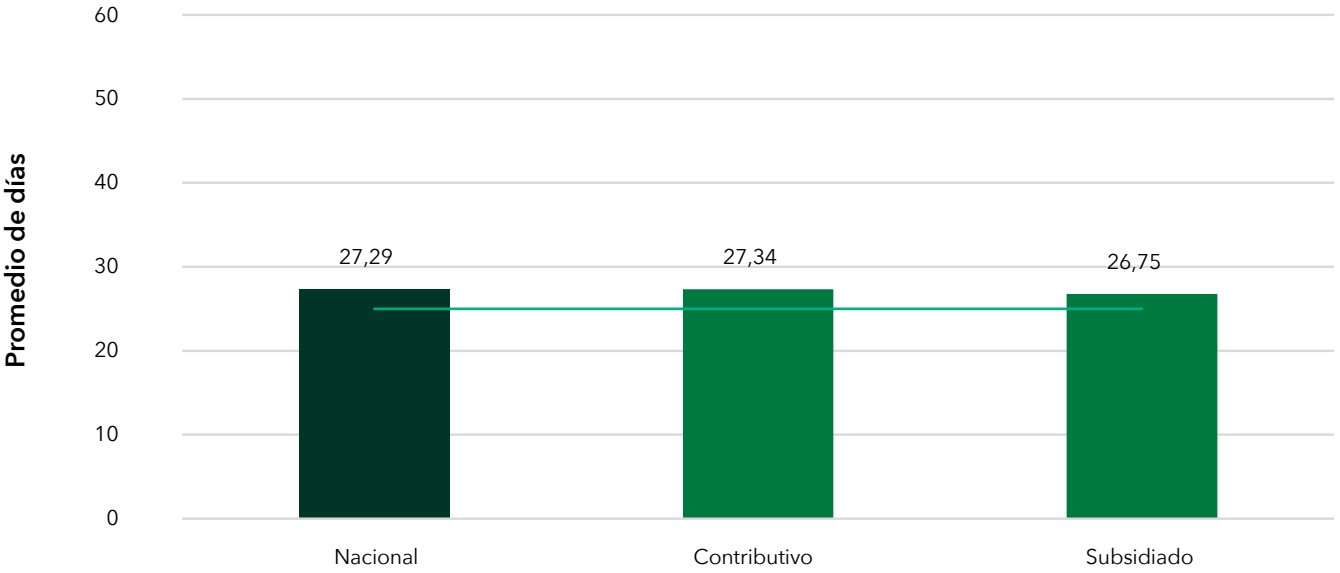


Tiempo transcurrido desde la realización de la mamografía o la consulta por presencia de síntomas hasta la confirmación diagnóstica.

Descargar figura

Con respecto al tiempo entre la atención del médico tratante y el inicio del primer tratamiento, se evidenció un tiempo promedio de 27 días, similar a los calculados para los regímenes contributivo y subsidiado; este resultado supera en cerca de 2 días la nueva meta definida de los 25 días.

Figura 2.6. Oportunidad del inicio del tratamiento en los casos nuevos de cáncer de mama en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

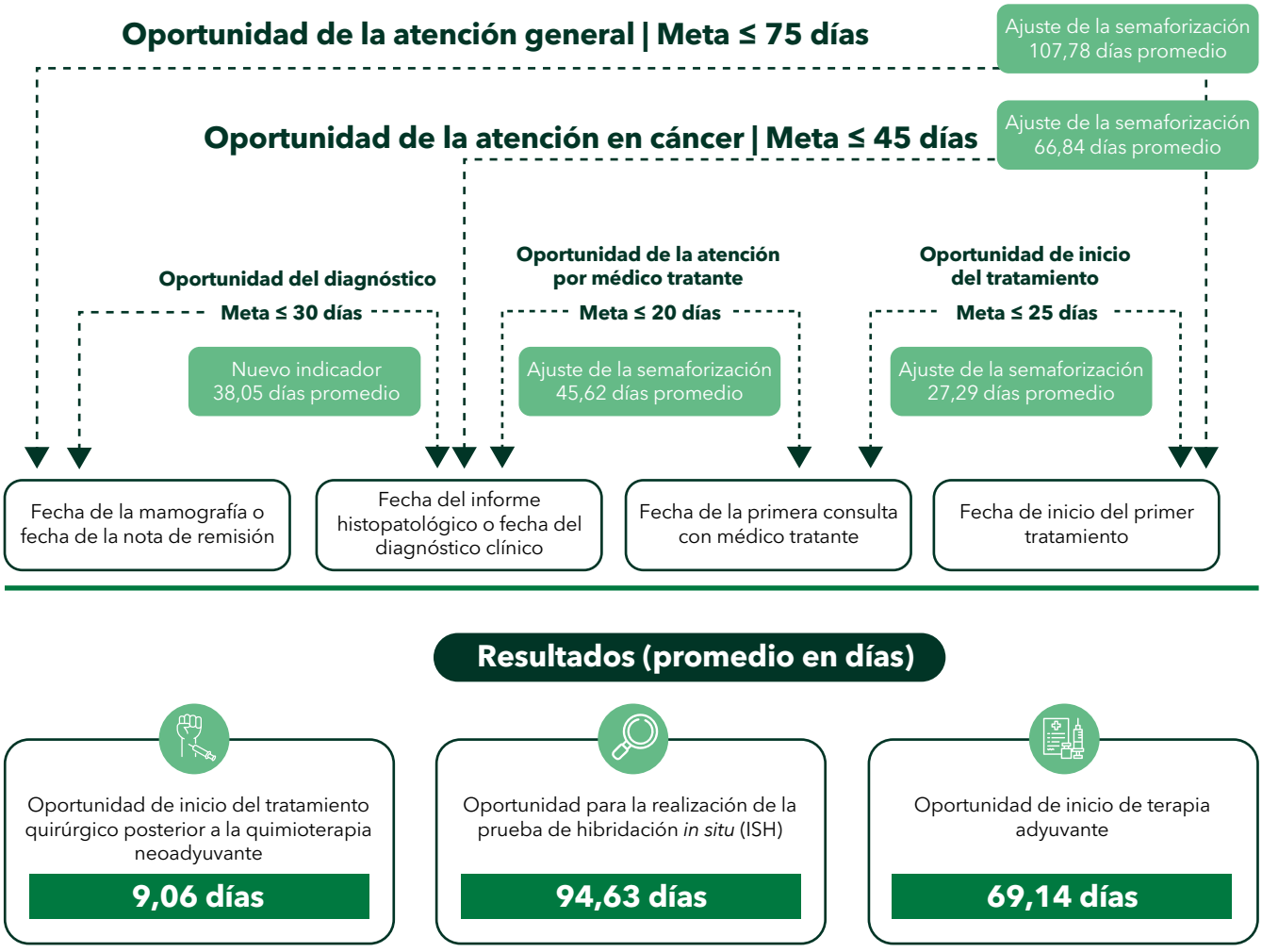


Tiempo entre la atención del médico tratante y el primer tratamiento.

Descargar figura

Con la actualización de los indicadores que evalúan la oportunidad de la atención, se definieron nuevos tiempos de seguimiento en la gestión y atención de las mujeres con este diagnóstico y algunos cambios en las metas, de acuerdo con los lineamientos de la política del Plan Decenal de Salud Pública 2022 - 2031 (3) y los lineamientos internacionales. En el siguiente esquema **(figura 2.7),** se muestran los resultados de la medición de estas oportunidades, así como los ajustes en los indicadores que se habían definido en el anterior consenso y los nuevos.

Figura 2.7. Esquema de las oportunidades en la atención de los casos nuevos de cáncer de mama en el marco del aseguramiento, Colombia 2025



Descargar figura

Los indicadores de gestión de la atención en las mujeres con cáncer de mama fueron modificados y actualizados en el consenso 2025, por lo que en este periodo se presentan sus primeras mediciones. En relación con la etapa diagnóstica, la estadificación de los casos nuevos se realizó en más del 90% en todo el territorio nacional; sin embargo, cerca del 40 % fue detectado en estadios avanzados, con proporciones superiores en las regiones Caribe y Amazonía-Orinoquía. Adicionalmente, en más del 90 % de los casos se confirmó el diagnóstico antes de la intervención quirúrgica.

En los casos nuevos residentes en Bogotá, D. C., y en la región Central fue más frecuente la realización de las pruebas de receptores hormonales y HER2, así como la de hibridación *in situ* (ISH) en quienes obtuvieron

resultado HER2 equívoco o indeterminado. Por otra parte, al 6,06 % de las mujeres menores de 50 años se les realizó la prueba de panel multigénico. La realización de estas pruebas cobra relevancia en tanto que las guías internacionales destacan la importancia de contar con una adecuada caracterización del perfil tumoral para definir el manejo clínico, incluyendo la cirugía, la radioterapia, la terapia endocrina, la terapia anti-HER2, la quimioterapia o la inmunoterapia, según el subtipo y el estadio de la enfermedad.

En cuanto al manejo terapéutico, la cirugía conservadora se realizó principalmente en los casos *in situ* (72,30 %) y localizados (79,54 %), y en menor proporción en los avanzados (43,97 %). Asimismo, menos del 50 % de los casos nuevos recibió radioterapia posterior a la cirugía o la terapia hormonal cuando el resultado fue positivo para los receptores hormonales. En contraste, la terapia anti-HER2 fue administrada en el 62,13 % de los casos con esta indicación, y el 56,16 % de los casos metastásicos confirmados durante el periodo recibió atenciones relacionadas con cuidado paliativo.

Finalmente, como parte de la actualización del consenso, se incluyeron indicadores de seguimiento relacionados con la fragmentación de la atención, la aplicación de escalas de calidad de vida, el cumplimiento de la terapia sistémica según indicación y el inicio del tratamiento con diagnóstico inmunohistoquímico incompleto. Estas mediciones son clave para evaluar no solo el acceso inicial al tratamiento, sino también la integralidad, oportunidad y calidad de la ruta oncológica. Los primeros resultados nacionales y regionales de estos indicadores se presentan en la **tabla 2.13.**

Tabla 2.13. Indicadores de la gestión del riesgo en cáncer de mama según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Número		1.1.	1.2.	2.	3.	4.1.	4.2.	5.	6.
Código[1]		MAM_22_1	MAM_22_2	MAM_23	MAM_24	MAM_25_1	MAM_25_2	MAM_26	MAM_27
Semaforización		≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 12 %	≥ 60 %	Por definir	Por definir	≥ 90 %	≥ 95 %
		80 a 90 %	80 a 90 %	6 a < 12 %	52 a < 60 %			≥ 70 a < 90 %	≥ 75 a < 95 %
		< 80 %	< 80 %	< 6 %	< 52 %			< 70 %	< 75 %
Región	Amazonía-Orinoquía	95,79	67,14	5,26	43,33	46,67	5,56	100,00	87,37
	Bogotá, D. C.	94,17	63,97	10,41	53,48	35,75	4,21	91,95	96,43
	Caribe	97,68	70,48	9,18	42,76	47,44	7,24	93,03	89,85
	Central	97,29	72,45	8,20	54,83	35,66	6,57	95,66	95,49
	Oriental	94,61	66,90	5,93	44,44	42,55	7,28	91,41	93,30
	Pacífica	94,41	67,90	8,47	45,64	41,15	7,10	93,71	89,72
Nacional		**95,85**	**68,69**	**8,57**	**49,15**	**39,95**	**6,35**	**93,62**	**93,36**

Tabla 2.13. Indicadores de la gestión del riesgo en cáncer de mama según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025 (continuación)

Número		7	7.1.	8.	10.1.	10.2.	10.3	11.
Código[1]		MAM_28	MAM_28_1	MAM_29	MAM_31_1	MAM_31_2	MAM_31_3	MAM_32
Semaforización		≥ 95 %	Por definir	≥ 90 %	≥ 90 %	Por definir	Por definir	≥ 90 %
				70 a < 90 %	70 a < 90 %			70 a < 90 %
				< 70 %	< 70 %			< 70 %
Región	Amazonía-Orinoquía	87,78	30,00	0,00	75,00	94,74	60,00	29,63
	Bogotá, D. C.	96,13	52,85	8,46	75,71	83,36	47,06	37,19
	Caribe	91,89	49,31	3,17	61,19	68,87	32,20	40,85
	Central	96,87	51,45	8,15	72,28	80,24	42,68	49,46
	Oriental	95,01	46,96	5,08	83,33	79,11	52,58	34,34
	Pacífica	92,36	45,95	3,85	75,58	84,19	54,40	40,48
Nacional		**94,71**	**49,66**	**6,06**	**72,30**	**79,54**	**43,97**	**41,91**

Tabla 2.13. Indicadores de la gestión del riesgo en cáncer de mama según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025 (continuación)

Número		12.	13.	14.1.	14.2.	15.	16.	17.
Código[1]		MAM_33	MAM_34	MAM_35_1	MAM_35_2	MAM_36	MAM_37	MAM_38
Semaforización		≥ 90 %	≥ 90 %	Por definir	Por definir	≥ 95 %	≤ 75 días	≤ 45 días
		80 a < 90 %	≥ 54,1 a < 90 %			90 a < 95 %	≤ 90 a > 75 días	≤ 60 a > 45 días
		< 80 %	< 54,1 %			< 90 %	> 90 días	> 60 días
Región	Amazonía-Orinoquía	19,35	55,56	40,00	19,44	25,00	167,22	102,87
	Bogotá, D. C.	34,59	69,33	58,67	28,69	18,99	89,74	62,24
	Caribe	41,61	58,90	55,17	23,85	13,97	110,87	56,91
	Central	48,40	66,89	68,03	39,51	38,20	94,84	55,22
	Oriental	27,27	52,59	42,70	19,11	13,16	138,21	92,99
	Pacífica	41,19	58,06	49,37	22,37	29,09	124,96	81,78
Nacional		**39,39**	**62,13**	**56,16**	**28,09**	**25,31**	**107,78**	**66,84**

Tabla 2.13. Indicadores de la gestión del riesgo en cáncer de mama según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025 (continuación)

Número		18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.1.
Código[1]		MAM_39	MAM_40	MAM_41	MAM_42	MAM_43	MAM_44	MAM_18_1
Semaforización		≤ 20 días	≤ 25 días	≤ 42 días	≤ 42 días	≤ 30 días	Por definir	≤ 1,3 %
		≤ 35 a > 20 días	≤ 40 a > 25 días	≤ 56 a > 42 días	≤ 56 a > 42 días	≤ 45 a > 30 días		> 1,3 a ≤ 2 %
		> 35 días	> 40 días	> 56 días	> 56 días	> 45 días		> 2 %
Región	Amazonía-Orinoquía	74,42	40,52	65,27	3,74	54,46	185,00	1,74
	Bogotá, D. C.	42,29	25,00	75,31	9,35	29,59	109,70	1,43
	Caribe	37,94	22,54	75,63	8,48	48,61	87,83	2,14
	Central	36,34	24,45	59,48	11,80	35,43	67,98	1,96
	Oriental	62,18	38,47	80,37	6,41	41,22	105,66	1,68
	Pacífica	60,60	31,44	64,25	7,85	37,50	83,06	2,57
Nacional		**45,62**	**27,29**	**69,14**	**9,06**	**38,05**	**94,63**	**1,92**

Tabla 2.13. Indicadores de la gestión del riesgo en cáncer de mama según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025 (continuación)

Número		24.2.	27.	28.	29.	30.1.	30.2.	31.
Código[1]		MAM_18_2	MAM_45	MAM_46	MAM_47	MAM_48_1	MAM_48_2	MAM_49
Semaforización		≤ 4,4 %	Por definir	0 %	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
		> 4,4 a ≤ 5 %						
		> 5 %		> 0 %				
Región	Amazonía-Orinoquía	7,91	2,68	20,48	19,74	0,97	0,08	23,89
	Bogotá, D.C.	5,33	3,03	10,03	22,36	10,86	0,91	9,86
	Caribe	7,03	3,45	13,85	27,05	4,83	0,48	7,93
	Central	5,42	4,17	7,39	19,87	3,94	0,37	5,21
	Oriental	6,17	2,81	13,26	21,81	6,26	0,63	16,18
	Pacífica	6,26	3,12	13,63	16,66	3,65	0,31	9,25
Nacional		**6,00**	**3,46**	**11,13**	**21,35**	**6,00**	**0,53**	**9,16**

[1] Código del indicador en HIGIA.

Referencias bibliográficas

1. Cuenta de Alto Costo. Consenso basado en evidencia de indicadores de gestión del riesgo por parte de aseguradores y prestadores en pacientes con cáncer de mama y cuello uterino en Colombia. 2016. 1–115 p.
2. Cuenta de Alto Costos. Informe especial: Resultados de supervivencia global en las personas atendidas en el marco del sistema de salud colombiano y notificadas a la Cuenta de Alto Costo, 2014 - 2022 [en línea]. Bogotá, D. C.; abril de 2025 [citado el 20 de abril de 2025]. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/publicaciones/informe-de-supervivencia-2014-2022/
3. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 2367 de 2023. Bogotá, D. C.; el 29 de diciembre de 2023.